

WEEKLY REPORT



小編：伊君

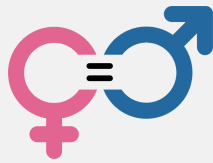
教學中心 & 實證醫學暨醫療政策中心週戰報

FRIENDLINESS



友善

EQUALITY



平等

ART



藝術

INSIGHT

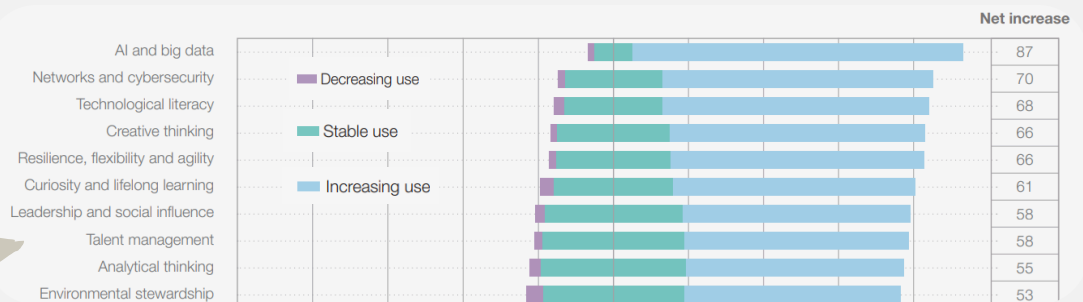


洞察力

走向未來，從不停止學習開始

世界經濟論壇日前公布了一份令人深思的《未來就業報告》，報告中點出未來職場最需要的關鍵能力包括分析思考能力、韌性靈活敏捷能力、領導力與社會影響力、創新思維能力、科技素養能力等。這些能力不僅對企業界相當重要，對醫療界也有深遠的影響。當科技浪潮席捲而來，人工智慧與數位轉型日新月異，我們不禁要問自己：「在這快速變遷的世界中，我們準備好了嗎？」

2025 至 2030 崛起中的 10 大核心技能



醫療產業素來以穩定、專業與細膩聞名，但過去幾年全球疫情肆虐，也使得醫療產業的數位轉型步伐加速，甚至已超越許多人的想像。遠距醫療、AI輔助診斷系統、醫療大數據分析逐步改變傳統的醫療服務模式，醫護人員被迫快速適應並且持續學習。面對這樣的轉變，許多資深的醫護人員也曾感到焦慮，擔心自己能否跟上腳步，更害怕未來是否會被淘汰。

但同樣地，這種變革也帶來前所未有的機會。醫療科技的發展不僅能提升病人照護的效率與品質，也能讓醫療人員從重複性工作中解放，回歸到更需要人性關懷與創造性思考的崗位。如何利用這些新工具來增進醫療效能，取決於我們是否願意擁抱新的知識與技能。

身為醫院的一份子，無論您身處哪個職位，都可以審視自己的能力清單，並思考如何為未來的挑戰做好準備。這不僅是為了自身的職涯發展，更是為了能持續提供最優質的醫療服務。

末期心臟衰竭的外科治療趨勢

在生與死之間，醫療如何讓希望繼續跳動？

每年，全台約有60至90位病人接受心臟移植。自1988年迄今，三總已完成281例，其中2023年更以22例，居全台之冠。為爭取寶貴的生命時間，三總更是率先引進了OCS(ORGAN CARE SYSTEM)系統，讓捐贈的心臟在運輸途中持續跳動，彷彿希望之火永不熄滅。



June 18 **末期心臟衰竭的**
外科治療趨勢

Wednesday
7:30AM-8:30AM
第五醫療大樓5樓國際會議廳

主講 國防部軍醫局局長 **蔡建松中將**
主持 陳志成副院長

回顧三軍總醫院心臟移植現況，並介紹心臟移植適應症、捐贈者和接受者標準及手術方法；對於末期心臟衰竭患者的治療策略，包括使用葉克膜(ECMO)的時機及轉換為心室輔助器(VAD)的臨床判斷標準，並摘要說明心室輔助器(VAD)的功能與類型，包含短期輔助器(CentriMag)和長期輔助器(HM3)。

接續介紹CentriMag的特性，包括流速、轉速、灌注量、連接器、最大工作壓力等，以及CentriMag的手術配置過程，包括插管技術、排氣和連接步驟。輔以實際個案解釋CentriMag如何幫助不同病因的心臟衰竭患者度過危急狀態，並為後續治療提供重要的時間窗口。

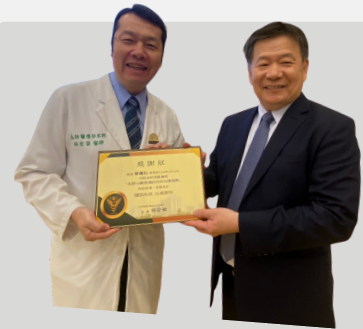
最後總結三軍總醫院使用CentriMag的經驗，包括使用CentriMag優點、併發症發生率以及影響患者存活率的風險因素，探討心室輔助器(VAD)在台灣的未来發展趨勢。

- 醫師、專師繼續教育「專業」學分1.2分
- 臨床教師認證A類a「生理」1學分
- 科部外教學績積分
- CFD一般課程5點

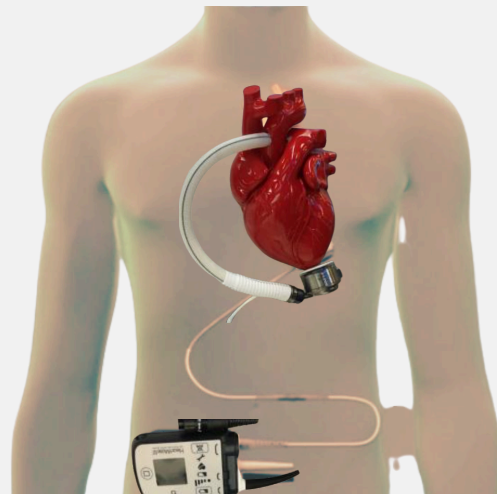
主辦 | 奇美醫院醫學教育委員會 協辦 | 國立中山大學學士後醫學系

但器官稀缺、時間緊迫，並非每個病人都能即時獲得心臟移植。三總深知此困境，積極採用「機械式循環輔助器」(MCS)：葉克膜(ECMO)、心室輔助器(VAD)、短期輔助器(CENTRIMAG)、長期輔助器(HEARTMATE 3)，成為末期心衰病人通往新生的橋梁。特別是「CENTRIMAG心室輔助器」，猶如病人體內小巧卻強大的「人工心臟」，可近乎完整取代心臟功能，成功率大幅超越傳統的ECMO，它是體外的心臟支持系統，需要住院治療。而HEARTMATE 3雖需要植入心臟，但允許病人出院，恢復較正常的生活方式。

心臟移植和 VAD 手術需大量人力與團隊合作，更需要一位領導者成為團隊的明燈，為絕望中的病人打開一道希望之門。



ECMO



HEARTMATE 3- 第三代 VAD



CENTRIMAG

醫療隱私守護戰：你的病歷比你想像的更珍貴

當你躺在診療台上，對醫師坦露身體的不適時，你是否想過這些私密資訊會如何被保護？醫療資訊就像是一把雙面刃。它是醫病信任的基石，讓醫師能準確診斷、妥善治療；但也因為它的好取得，反而成了隱私洩漏的高風險標的。想像一下：一個好奇的員工偷看了主管的健檢報告，一封誤寄的電子郵件讓病歷外流，或是駭客入侵系統竊取了數千筆病人的資料。

醫院的三道防線

面對這些威脅，醫療機構其實已經築起了三道防線：

第一道：技術鐵壁 就像銀行金庫一樣，病歷系統採用層層加密，定期進行安全檢查，並設置嚴格的權限管理。不是每個人都能隨意查看任何病歷，系統會記住誰、何時、看了什麼。

第二道：人心防護 醫院定期宣導，提醒每位員工都要有隱私保護意識。

第三道：法律震懾 《個人資料保護法》可不是開玩笑的。單一洩漏事件的**集體求償可高達兩億元**，還可能面臨刑事責任。這不只是罰錢的問題，更是職業生涯的終結。



大數據時代的智慧監控

現在的醫院就像有隻「電子鷹眼」在監控。如果某份病歷在一天內被查閱超過 **30** 次，系統會立刻發出警報；每個月病歷資訊管理室也會進行抽查，就像稽查員突擊檢查一樣。非業務相關的查閱行為須先說明理由並經主管核准，否則可能面臨記大過的處分。

同仁專區

破繭而出



分享者：教學中心淑怡

從傳統行政到數位賦能，我在奇美教學中心的轉型之路

在奇美醫院教學中心服務了18年，時間彷彿是我最熟悉的刻度，標記著一屆又一屆實習醫學生的成長，也記錄著日復一日、年復一年的行政軌跡。我的工作，是為一張張年輕臉孔辦理職前訓練，為他們排定於各科部的學習地圖及建立學員們的評估與回饋。從統計學員票選的「最佳值班教學醫師」，到帶領他們參訪奇美博物館，感受醫學與人文的交織；從每月核算繁瑣的教學費用，到處理評鑑時堆積如山的文件，這一切，都建構了我對這份工作的成就感。

然而，這樣的日常在去年教學醫院評鑑結束，隨著廖家德主任接任教學中心副主任後，迎來了前所未有的轉變。**起初**，面對「全球醫學教育趨勢」、「數位賦能」、「QCC品質改善」等一連串陌生的詞彙與要求，坦白說，**內心其實充滿著惶恐與抗拒**，擔心自己是否跟得上這快速的數位時代。但隨著一步步的引導，也深刻體會到這場「轉型」的真正意涵，它不僅是為了跟上時代，更是為了重新定義我們身為教學行政人員的核心價值。



去年底由廖主任帶領教學中心舉辦「教學共識營」又是另一項結構性的改變，並劃分出四大轉型主軸：數位賦能、醫學人文、師資培育及CMBE評估。而藉由此次的教學共識營，首次接觸到數位賦能的概念。作為一個習慣傳統作業模式的我，學習如何運用AI工具來完成影片製作和簡報設計，確實是一大挑戰。然而，透過實際操作和同仁間的互相學習，逐漸發現這些數位工具不僅能提高工作效率，更能激發創意思考。特別是在配合院方推動的無紙化數位時代政策下，這些技能的掌握變得更加重要。



與此同時，我們也**首次參與了「QCC品管圈活動」**。透過QCC手法的導入，我們學習如何以科學化、系統化的方式，發掘教學流程中的核心問題，並提出具體改善方案。自今年3月開始，單位分成兩組並分別進行密集的小組會議及定期與顧問召開輔導會，過程雖然非常的艱辛及腦汁快噴發的狀態，卻也讓我們有初步的概念：**如何運用PDCA及數據分析進行問題解構與行動實踐，如何將「抽象的品質提升」，轉化為具體可行的步驟**。而兩組教學QCC也將於7月17日進行期中發表，這不僅是極大的挑戰，也是我們首次的重要里程碑！

「每位同仁皆須具備數位賦能能力」，這是廖主任給我們的明確目標。原本專注於既定的工作流程，突然要重新審視自己的特質、影響力和價值，確實需要很大的勇氣。於是在主任的帶領下，我們開始學習運用AI來規劃個人的職涯發展，並與主任進行面談。這項作業與過去的工作內容截然不同，透過AI及面談來審視個人職涯分析，卻也是一次深刻的自我對話。



回顧這段轉型歷程，感謝主任的帶領及單位給予的機會與挑戰。從最初的困惑和害怕，到現在的接受及改變，雖然我走(學習)的比其他同仁慢一些，也期許自己努力跟上。而這改變的過程讓我重新認識了自己，也重新定義了工作的意義，在這數位化的時代，我們必須具備持續學習和適應變化的能力。期待在這條蛻變的道路上，與團隊夥伴們一同前行，持續學習、不斷進化。

音樂家 - 雷利·班·金

THE BEAUTIFUL THING ABOUT LEARNING IS
NOBODY CAN TAKE IT AWAY FROM YOU .

學習的美好之處，是沒有人可以
把它從你身上拿走。